| Nome do Documento | USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EM BAIXA DOSE PARA PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA | | |
|---|---|---|---|
| **Data da Emissão** | 02/10/2025 | **Tipo de Documento** | NOTA TÉCNICA |
| **Emitido Por** | ATENÇÃO PRIMÁRIA | **Revisado por** | Dra. Marislene P. C. Nunes |
| **Aprovado Por** | Thereza Christina Griep (Secretária de Saúde) | **Nº Revisão** | 01 |

## 1. Introdução

A pré-eclâmpsia permanece como uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. Evidências científicas consistentes demonstram que o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) em baixa dose, iniciado precocemente em gestantes com fatores de risco, reduz significativamente a incidência e a gravidade da doença.

## 2. Justificativa

Apesar da existência de diretrizes nacionais e internacionais (USPSTF, FEBRASGO, RBEHG, NICE), a ausência de padronização municipal gera insegurança assistencial, heterogeneidade de condutas e vulnerabilidade legal para os profissionais de saúde.
Diante disso, esta Nota Técnica tem por objetivo uniformizar a prática clínica no âmbito do município, conferindo respaldo científico e jurídico aos profissionais, promovendo equidade no cuidado pré-natal e contribuindo para a redução das complicações relacionadas a pré-eclâmpsia.

## 3. Classificação de Risco e Indicação

### Alto Risco

- História de pré-eclâmpsia, especialmente associada a desfecho adverso.
- Gestação gemelar.
- Hipertensão crônica.
- Diabetes mellitus tipo 1 ou 2 pré-gestacional.
- Doença renal crônica.
- Doença autoimune (ex.: lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolípide).
- Obesidade (IMC pré-gestacional ≥ 30 kg/m²)
- Gestação decorrente de reprodução assistida (fertilização in vitro)
- Combinação de múltiplos fatores de risco moderado.

### Recomendação:

Indicar **AAS 100 mg/dia** se a paciente apresentar **≥ 1 fator de alto risco**.

Risco Moderado

- Nuliparidade.
- História familiar de pré-eclâmpsia (mãe ou irmã).
- Condição socioeconômica desfavorável
- Etnia/Cor: preta ou parda
- Idade materna ≥ 35 anos.
- Histórico pessoal de desfecho gestacional adverso relacionado a disfunção placentária (descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, óbito fetal)
- Intervalo intergestacional >10 anos.

Recomendação:
Indicar **AAS 100 mg/dia** se a paciente apresentar **≥ 2 fatores de risco moderado**.

---

Baixo Risco

- Gestantes com parto anterior de termo, sem complicações, e sem os fatores descritos acima.

Recomendação:
Não indicar AAS.

---

4. Posologia e Duração

- **Dose:** 100 mg/dia.
- **Horário:** 01 comprimido de 100 mg preferencialmente à noite.
- **Início:** Entre **12 e 16 semanas, iniciando o mais precoce possível** (aceitável até 20 semanas, com menor benefício).
- **Suspensão:** Com **36 semanas** de gestação (aceitável até o fim da gestação).

---

5. Avaliação de Risco x Benefício

Benefícios comprovados:

- Redução de pré-eclâmpsia/eclâmpsia.
- Redução de parto prematuro.
- Menor risco de restrição de crescimento intrauterino/pequeno para idade gestacional.
- Redução da mortalidade perinatal.

Riscos:

- Não há evidências de aumento significativo de efeitos adversos graves com uso diário de AAS em baixa dose.

Contraindicações:

- Alergia a AAS
- Asma induzida por AINEs
- Sangramentos ativos
- Úlcera péptica ativa
- Risco elevado de hemorragia
- Insuficiência hepática grave
- Insuficiência renal grave

## 6. Considerações Finais

- Este protocolo aplica-se a todas as unidades de saúde municipais.
- A equipe de pré-natal deve identificar precocemente gestantes elegíveis para profilaxia com AAS.

## 7. Referências

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE). Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. NICE guideline [NG133]. London: NICE, 2019. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng133>. Acesso em: 3 out. 2025.

UNITED STATES. U.S. Preventive Services Task Force. Aspirin use to prevent preeclampsia and related morbidity and mortality: preventive medication. JAMA, Chicago, v. 326, n. 12, p. 1186-1191, 2021.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). Predição e prevenção da pré-eclâmpsia: posicionamento da Comissão Nacional Especializada em Hipertensão na Gravidez. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

REDE BRASILEIRA DE ESTUDOS SOBRE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ (RBEHG). Protocolo de pré-eclâmpsia. Belo Horizonte: RBEHG, 2025. Disponível em: <https://rbehg.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

| Nome e Função | Assinatura |
|---|---|
| Thereza Christina Griep<br>Secretária Municipal de Saúde | THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024<br>Assinado de forma digital por THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024<br>Dados: 2025.11.10 14:53:33 -03'00' |
| Dra. Ana Helena Bitencourt Alamy<br>Médica Referência Técnica em Ginecologia e Obstetrícia | gov.br<br>Documento assinado digitalmente<br>ANA HELENA BITTENCOURT ALAMY<br>Data: 10/11/2025 14:04:01-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |
| Dra. Marislene Pulsena da Cunha Nunes<br>Coordenadora da Atenção Primária | gov.br<br>Documento assinado digitalmente<br>MARISLENE PULSENA DA CUNHA NUNES<br>Data: 30/10/2025 20:43:02-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |
| Dr. Mateus da Silva Ferro<br>Coordenador Adjunto da Atenção Primária | gov.br<br>Documento assinado digitalmente<br>MATEUS DA SILVA FERRO<br>Data: 23/10/2025 11:43:51-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |
| Dr. Smalley Martins Ribeiro<br>Coordenador Adjunto da Atenção Primária | gov.br<br>Documento assinado digitalmente<br>SMALLEY MARTINS RIBEIRO<br>Data: 23/10/2025 11:47:31-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |